Capitolul 2 DIAGNOSTICUL PRENATAL

Obiectivele consultațiilor prenatale sunt scăderea mortalității materne, a incidenței prematurității, a mortalității perinatale, a numărului de malformații congenitale şi a persoanelor cu handicap. Măsurile profilactice prenatale cuprind examenul prenupțial, sfatul genetic, examenele prenatale de dispensarizare a sarcinii, metodele de diagnostic ale malformațiilor sau bolilor congenitale.

EXAMENUL PRENUPȚIAL

Deşi tot mai mulți copiii se nasc în afara unei căsătorii, examenul prenupțial nu şi-a pierdut utilitatea. Pentru soț şi soție se va efectua un examen clinic complet (pentru diagnosticul afecțiunilor contagioase şi ereditare). Trebuie propusă după consiliere efectuarea testării HIV şi se va efectua testarea pentru screeningul infecției luetice.

Pentru femeile cu vârsta sub 50 de ani se vor testa serologia pentru rubeolă şi toxoplasmoză în absența dovedirii prin documente a imunității pentru aceste boli. Se va stabili grupa sanguină şi Rh pentru ambii soți. În cazul cuplurilor Rh negativ – soția şi Rh pozitiv – soțul pentru a se preveni izoimunizarea se recomandă a se administra gamaglobulină antiRh în primele 72 ore după avort sau naştere. Se recomandă efectuarea unei radiografii pulmonare pentru ambii soți.

Medicul trebuie să comunice constatările medicale făcute persoanei examinate. În cazul unor boli grave trebuie păstrat un document scris al acestei consultații medicale. Se vor face recomandări privind planificarea familială şi se va recomanda consult genetic în cazul diagnosticului unei afecțiuni genetice.

Se va elibera certificatul prenupțial cu datele necesare.

SFATUL GENETIC

2% din nou-născuți au o malformație congenitală majoră, 1% au o anomalie genică şi 0,4% au o boală cromosomială. Marea majoritate a nou-născuților nu au o afecțiune cu transmitere ereditară evidentă. Modificările cromosomiale survin în timpul meiozei şi în primele stadii de dezvoltare a zigotului. Acestea pot privi numărul de cromosomi (trisomie 13, 18, 21 sau monosomie X...) sau structura cromosomilor (deleții, translocații...). Bolile genice apar fie datorită unei mutații la nivelul unei singure gene (ereditate monofactorială) sau afectarea mai multor gene (ereditate multifactorială). Sunt inventariate aproximativ 4.000 de boli genice cunoscute sau suspectate, dar doar 170 pot fi diagnosticate antenatal. Malformațiile congenitale izolate sunt datorate cel mai frecvent eredității multifactoriale.

Pacientele cu factori de risc pentru afecțiuni genetice sunt cele cu:

1. Antecedente personale sau familiale de boli ereditare.

- ***Boli ereditare monofactoriale sau mendeliene.*** Ele sunt depistate prin studii de genetică moleculară care studiază ADN-ul ca material biologic, indiferent de celulele fetale prelevate.
- ***Boli autosomale dominante:*** acondroplazie, coreea Huntington, boala Marfan, miotonia Steinert. 50 % din descendenți sunt afectați, indiferent de sex. Când un cuplu este sănătos, neafectat de boală, nu există riscuri pentru descendenți.
- ***Boli autosomale recesive***: mucoviscidoză, drepanocitosă, talasemie. Copii sunt a priori indemni dacă unul din părinți este indemn, dar toți sunt purtători al bolii independent de sex. În caz de consanguinitate, când ambii părinți sunt heterozigoți, 25% din copii sunt afectați. Pentru unele din aceste boli, depistajul heterozigoților este posibil prin biologie moleculară şi această confirmă importanța sfatului genetic preconcepțional.
- ***Boli ereditare legate de sex***: miopatie Duchenne, hemofilia, sindromul X fragil... Bolile sunt transmise în special de către femei. Băieții sunt afectați unul din doi, iar fetițele sunt purtătoare una din două. Diagnosticul este adesea posibil, fie prin analiză a ADN-ului din celulele fetale recoltate prin biopsie de trofoblast, amniocenteză, fie prin diagnosticul sexului fetal (diagnosticul de sex masculin poate determina recurgerea la întrerupere de sarcină cu un risc de 1 din 2 ca fătul să fie sănătos).

- ***Boli genetice metabolice*** (hemofilie A şi uneori B, hemocromatoză, hiperplazie congenitală de suprarenală...). Aceste boli pot fi depistate prin analiza activității enzimatice şi uneori prin eliminarea urinară fetală a unui metabolit specific. Aceste boli pot avea o transmitere mendeliană.

2. Antecedente personale sau familiale de boli cromosomiale (trisomiile 21, 18, 13, monosomia X (sindromul Turner), sindromul Klinefelter XXY...

Influența vârstei materne asupra incidenței trisomiei 21 este cunoscută şi prezentată în tabelul de mai jos:

Vârsta maternă	**Risc**
< 25 ani	1/2 000
30 ani	1/1 000
35 ani	1/350
38 ani	1/100
40 ani	2/100
42 ani	4/100
> 45 ani	6 - 8/100

Examenul genetic este recomandat de la un risc de **1 %,** adică după 38 ani în ziua puncției.

NB: În caz de trisomie 21 liberă într-o fratrie – adică un frate sau o soră este afectată de trisomia 21 – riscul de recurență este de 1 %. Este justificată efectuarea unui cariotip precoce în cursul sarcinii.

3. Antecedente personale sau familiale de malformații congenitale. Rolul factorilor genetici în apariția acestora este puțin cunoscut fiind implicat mai ales ereditatea multifactorială. Estimarea riscului este empirică, bazată pe experiența obținută în situații comparabile. Riscul este în general redus, sub 5%, chiar dacă există numeroase cazuri în familie.

4. Antecedente personale sau familiale de nou-născut mort ± malformat. Conduita depinde de diagnosticul corect stabilit în momentul decesului fetal. Se poate recomanda o ecografie endovaginală la 12-14 SA şi o ecografie morfologică fetală la 22-24 SA. Cariotipul fetal se poate efectua în funcție de tipul (tipurile) malformației (malformațiilor).